EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 93800
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-09-30 15:30:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CARLOS ALBERTO ESCOBAR SALDIA			RUN	: 10.777.296-0
F.Nac	: 24-04-1966	Edad	: 58 AÑOS, 5 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: PANAM.SUR KM.370			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-09-22	Fecha Egreso	: 2024-09-30 15:30:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Síndrome afásico: afasia global en recuperación
1.1 ACV isquémico Fronto- insular izquierdo
1.2 Posible etiología indeterminada
2. TVP infrapoplítea derecha en TACO
3. IAM previo por antecedentes
4. Ceguera mono-ocular traumática por antededente

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I82.8-EMBOLIA Y TROMBOSIS DE OTRAS VENAS ESPECIFICADAS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. H54.4-CEGUERA MONOCULAR (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes médicos: HTA/ IAM previo/ TVP infrapoplítea derecha en TACO/ ceguera monoocular izquierda antigua
Fármacos: dabigatrán 150 mg cada 12 horas
Alergias: niega

Paciente masculino de 58 años con antecedentes descritos. Familiar (esposa) refiere inicio de cuadro clínico ayer (22/09) en horas de la mañana cuando al despertar presenta dificultad para la producción y comprensión del lenguaje (refiere última vez visto bien a las 00:30 horas). En este contexto es trasladado a SU HSC. En contexto de wake up stroke se realiza TAC + angioTAC de cerebro y cuello donde se observa lesión hipodensa fronto- insular izquierda con compromiso opercular de aspecto sub- agudo, con imagen sugerente de trombo de ACM izquierda en segmento M2 proximal. En este contexto se presenta a HCHM y posteriormente a HGCB para eventual trombectomía mecánica la cual se desestima por tiempo de evolución y ASPECT 6 puntos. En este contexto se decide ingreso médico para manejo médico intrahospitalario, completar estudios complementarios y realización de terapia de rehabilitación.

EVOLUCIÓN INTRAHOSPITALARIA
* NEUROLÓGICO: paciente que ingresa en regulares condiciones generales. A su ingreso se evidencia déficit neurológico caracterizado por afasia global. No se observan déficit motor y/o sensitivo asociado. Paciente que durante hospitalización presenta mejoría clínica con mejoría parcial en denominción de palabras y objetos y comprensión de órdenes, frases y contextos. Se realiza terapia de rehabilitación integral con énfasis en terapia del lenguaje con fonoaudiología y terapia ocupacional. Se trabaja en la comprensión de objetos de baja y alta frecuencia, denominación de partes del cuerpo y comprensión de órdenes, logrando denominación con facilitación. Se realiza estimulación temporo- espacial, estimulación cognitiva, enfrentamiento de AB y AIVD. En contexto de buena evolución clínica, sin complicaciones clínicas ni radiológicas, se decide alta médica con seguimiento or HODOM para continuar terapia de rehabilitación y posterior control en policínico de neurología y rehabilitación.

NOTA: se realiza estudio cardiovascular (Ecocardiograma T-T con test de burbuja) en contexto de TVP infrapoplítea derecha. Se descarta presencia de CIA, mas se evidencia dilatación moderada de aurícula izquierda (45 mm). En este contexto como posible fuente cardiembólica asociado a TVP previa parcialmente recanalizada, se decide re-inicio de terapia anticoagulante con NOAC cada 12 horas.

EXAMEN NEUROLÓGICO DE ALTA:
Signos vitales;
PA: 118/64 mmHg FC: 50 LPM/ FR: 16 RPM/ SAT02 93% FIO2 21%
EXAMEN NEUROLÓGICO:
- MENTAL: vigil espontáneo, orientado en tiempo y espacio. Lenguaje con afasia global nomina 3/5, repite 3/5 con leve dificultad, comprende órdenes simples de forma parcial y con facilitación. Fluencia conservada. Presencia de parafasias semánticas.
- PC: se observa leucocorea en ojo izquierdo. Pupila derecha normoreactiva. RFM directo + a derecha. CV impresiona con hemianopsia homónima derecha a la amenaza. MOE conjugados sin mirada preferente. Simetría facial bilateral. Protruye lengua en línea media (por imitación)
- MOTOR: fuerza M5 global en 4 EE. PMP negativa en 4 EE. REM ++/++. RCP extensor a derecha
- SENSITIVO: retiro simétrico a estímulos dolorosos apendiculares en 4 EE.
- TAXIAS: metría y diadococinesia impresionan conservadas
- SIGNOS MENÍNGEOS NEGATIVOS
NIHSS: 5 puntos

PLAN DE MANEJO:

1. Mantener terapia anticoagulante con dabigatran 150 mg cada 12 horas.
2. Evaluación por HODOM para continuar terapia de rehabilitación del lenguaje
3. Realizar de forma ambulatoria HOLTER DEL RITMO DE 72 HORAS
4. Control en policlínico de neurología en 15-30 días con resultado de Holter.

INDICACIONES AL ALTA

1. 1. Reposo relativo. Iniciar paulatinamente actividades diarias.
2. 2. Dieta estilo mediterránea: Procure tomar alimentos ricos en fibra, minerales y antioxidantes. Tome al menos tres piezas de fruta al día, preferentemente de temporada y un puñado de
3. frutos secos crudos (nueces, almendras…) 3 a 7 veces por semana; evite los frutos secos
4. procesados por que pueden perder sus propiedades y/o o les pueden añadir grasas no
5. saludables. Incorpore diariamente a su dieta cereales y derivados preferentemente integrales (pan, arroz, pasta…). Coma legumbres entre dos y cuatro veces por semana.
6. - Tome verduras y hortalizas al menos dos veces al día. Una de las tomas que sean crudas
7. (ensaladas generalmente). Use preferentemente aceite de oliva virgen tanto para cocinar como para condimentar ensaladas. Disminuya en su dieta el consumo de grasas animales (como mantequilla, tocino, bollería industrial, carnes grasas, embutidos, quesos, bacon, natas).
8. 3. Dabigratan 150 mg: 1 comprimido vía oral cada 12 horas (hasta nuevo asviso)
9. 4. Omeprazol 20 mg: 1 capsula vía oral diario en ayunas
10. 5. Holter del ritmo de 72 horas.
11. 6. Control en policlínico de neurología (Dr. Roger Molleja) en 15-30 días con resultado de Holter
12. 7. Alta con hospitalización domiciliaria para contionuar terapia de rehabilitación del lenguaje con fonoaudiología.

EXÁMENES Y RESULTADOS

EXÁMANES REALIZADOS:
1. AngioTAC de cerebro y cuello (22/09): lesión hipodensa de aspecto isqémico agudo en región fronto-insular izquierda con compromiso opercular. Se observa oclusión tromboembólica en división superior de ACM izquierda en su porción M2 proximal. Sin evidencia de transformación hemorrágica.
2. TAC de cerebro control (23/09): Infarto de aspecto sub-agudo fronto- insular izquierda sin signos de transformación hemorrágica.
3. TAC de tórax/ abdomen/ pelvis con contraste (23/09): sin signos sugerentes de TEP. No se observan lesiones sugerentes de neoplasias. Nefrolitiasis izquierda. Cicatriz renal izquierda. Quistes renales simples.
4. Perfil trombofilia: NEGATIVO
5. Ecocardiograma T-T + Test de burbujas: ventrículo izquierdo no dilatado, con FEVI 70%. Sin trastornos de movilidad segmentaria. Aurícula izquierda moderadamente dilatada (45 mm). Función diastólica normal. Insuficiencia mitral leve. Sin dilataciones de cavidades derechas. Sin evidencia de microembolías ni CIA al test de burbujas.

OBSERVACIONES:

- Realizar de forma ambulatoria HOLTER DEL RITMO DE 72 HORAS
- Control en policlínico de neurología en 15-30 días con resultado de Holter.

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

ROGER DE JESUS MOLLEJA MARAIMA
MEDICO TRATANTE

JEFE SERVICIO

26127229-6